

COLLECTE DES PLAINTES

Une des tâches les plus difficiles est de déterminer avec précision pour quelles raisons le patient consulte. Le but est de déterminer **tous** les problèmes que le patient désire aborder. Une erreur fréquente est de croire que le patient ne consulte que pour une seule plainte. Une autre est de croire que la première plainte exprimée est la plus importante.

Souvent les médecins interrompent trop précocement le patient pour lui demander des précisions ou poser d'autres questions. Le problème est que très peu de patients parviennent ultérieurement à exprimer toutes leurs plaintes s'ils sont interrompus prématurément.

- **Commencez avec une question ouverte**

Une question ouverte est une question très neutre qui laisse le patient commencer à s'exprimer comme il le désire (*Que puis-je faire pour vous?*).

Une simple invitation à s'exprimer (*Je vous écoute*) est une excellente question ouverte.

- **Evitez d'interrompre prématurément**

- **Essayez de faciliter l'expression mais sans interrompre par des questions:**

- contact oculaire approprié;
- posture et gestuelle exprimant une écoute bienveillante;
- quelques ponctuations non verbales qui encourage l'expression (hum hum; gestes qui invitent à s'exprimer, hochements de tête, etc.);
- respecter les moments de silence pendant lesquels le patient réfléchit.

- **Demandez systématiquement si le patient a d'autres problèmes dont il veut parler**

- **Résumez au patient ce que vous avez compris** afin de vérifier qu'il n'y a pas de malentendus.

- **Négocier les buts de la consultation**

Une fois que vous avez collecté toutes les plaintes du patient, vous devez déterminer avec lui ce que vous allez aborder au cours de la consultation. Deux repères sont utiles :

- le temps que vous avez à disposition pour la consultation ;
- établir avec le patient des priorités en tenant compte de son point de vue et de votre opinion médicale.

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. EXPLORATION DE LA PLAINTÉ PRINCIPALE

Maintenant que vous avez établi avec le patient une liste de ses plaintes et que vous vous êtes mis d'accord avec lui sur les buts de la consultation, c'est le moment d'explorer en détail la plainte principale.

L'approche la plus efficace consiste à demander au patient de raconter librement son histoire avec ses mots à lui, de nouveau en évitant d'interrompre prématurément.

Quelques techniques d'entretien sont utiles :

1.1. Cône de questions

A nouveau il faut insister sur la valeur de commencer par des questions peu directives (ouvertes) et de progressivement devenir plus spécifique. Ainsi on débutera par une question qui laisse le patient dire son histoire avec ses mots et ses associations d'idées. Par exemple : “ *Racontez-moi en détail cette douleur que vous avez eue dans la poitrine* ”. C'est ultérieurement que des questions fermées (qui appelle une réponse spécifique) ont toute leur utilité. Par exemple : “ *Combien de temps cette douleur a-t-elle duré?* ”.

Des erreurs fréquemment observées sont de poser des questions :

- en utilisant du jargon médical ;
- plusieurs questions à la fois ;
- en suggérant une liste de réponse possible (comme dans un QCM).

1.2. Caractéristiques d'un symptôme

Certaines questions sont utiles pour déterminer avec un maximum de précision les caractéristiques d'une plainte et de l'intégrer dans le contexte de vie du patient.

En voici sept en prenant l'exemple d'une douleur abdominale :

1. **Localisation et irradiation:** Montrez-moi où était cette douleur dans le ventre? Se déplace-t-elle ou reste-t-elle localisée?
2. **Qualité:** Comment était cette douleur? Était-elle comme une brûlure? Comme une crampe?
3. **Quantité ou sévérité:** Donnez-moi une idée de l'intensité de cette douleur? A quel point cette douleur a-t-elle gêné vos activités habituelles?
4. **Décours temporel:** Dans quelles circonstances a-t-elle commencé ? Combien de temps a-t-elle duré? A quelle fréquence apparaît-elle ?
5. **Circonstances dans lesquelles la douleur apparaît:** Dans quel lieu ? Lors de quelles activités personnelles ? Dans quel contexte émotionnel ? Dans quelles autres circonstances ?
6. **Facteurs déclenchant et facteurs de sédation:** Avez-vous remarqué des facteurs qui déclenchaient / aggravaient la douleur? Qui la soulageaient ou la faisaient disparaître?
7. **Symptômes associés:** Avez-vous remarqué d'autres symptômes?

1.3. Clarifier les propos du malade

Si on insiste beaucoup sur la valeur des questions ouvertes, cela ne veut pas dire que les questions fermées en ont moins. Elles sont notamment extrêmement utiles pour **clarifier** les réponses d'un patient à une question ouverte.

1.4. Soutenir les émotions exprimées verbalement ou non verbalement

Quand les patients parlent, il y a des moments où les émotions que leur suscite leur problème se révèlent d'une manière plus ou moins explicite. Ils peuvent l'exprimer par des mots ou de manière non verbale. Ce sont des occasions d'exprimer au patient un soutien qui en lui-même a une valeur thérapeutique, et renforce considérablement la relation. Il est notamment très important que le patient se sente compris. Trois attitudes de base sont :

- **de montrer de l'empathie** (reformuler les émotions exprimées);
- **de légitimer** (exprimer que les émotions du patient sont compréhensibles);
- **de montrer son respect** pour les émotions exprimées.

1.5. Résumer et vérifier sa compréhension

Une fois que la plainte a été clarifiée, il est très utile que le médecin fasse un résumé de ce qu'il a compris. Cela permet d'identifier d'éventuels malentendus et permet au patient de compléter son histoire s'il le désire.

2. ETAPES DE L'ANAMNESE MEDICALE SYSTEMATIQUE

Une fois que toutes les plaintes ont été explorées en détail, il reste la plupart du temps des domaines qui n'ont pas été encore abordés ou qui doivent être complétés.

C'est alors que les listes d'anamnèse médicale systématique (antécédents personnels, antécédents familiaux, revue par systèmes, habitudes, anamnèse socioprofessionnelle) vous aident. Ces listes permettent également d'organiser l'ensemble de l'information concernant un patient dans un énoncé structuré très utile pour la rédaction d'un dossier médical.

Ces listes seront reprises et détaillées dans les séminaires de sémiologie et ne sont pas à connaître " par cœur " à ce stade.

Toutefois nous vous demandons de prendre connaissance des éléments répertoriés suivants sur le « Guide de consultation » (distribué lors du premier séminaire).

2.1. Antécédents personnels

- maladies antérieures;
- maladies psychiatriques;
- antécédents gynécologiques et obstétricaux
- traumatismes;
- interventions chirurgicales;
- hospitalisations;
- allergies;
- immunisations (vaccinations, sérothérapie);
- abus de substances : tabac, alcool, drogues;
- régime alimentaire ;
- tests de dépistages

2.2. Antécédents familiaux

Age et état de santé, âge et cause de décès de tous les parents directs : parents, frères et sœurs, conjoint, enfants, grands-parents, petits-enfants.

Survenue de maladie multifactorielle indiquant une composante génétique (par exemple diabète, cancer, maladies cardiaques, hypercholestérolémie, un risque de contagion (tuberculose), ou des problèmes sociaux (toxicomanie, alcoolisme).

2.3. Revue par systèmes

Sera abordée dans les séminaires de sémiologie.

2.4. Habitudes

- médicaments actuels;
- exercice physique et loisirs;

2.5. Anamnèse socioprofessionnelle

- situation à la maison;
- activités quotidiennes;
- activités professionnelles, exposition à des toxiques;
- importantes expériences de vie;
- croyances, culture.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Recommandations: Approches en communication pour le bon déroulement de la consultation, stratégies du Service de Médecine de Premier Recours 2009 n° 31. N. Junod et J. Sommer
- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 1th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 3-13. WB 205 1

POUR EN SAVOIR PLUS

- Silverman J, Kurtz S., Draper J. Outils et stratégies pour communiquer avec le patient. Edition Méd. et Hyg. 2010 Chapitre 2, pp 69-94 et chapitre 3 pp 95-152.
- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 65-82. WB 205 1

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Ce séminaire se déroule en deux phases.

La première phase est destinée à découvrir les quatre outils fondamentaux de l'examen physique et à les appliquer.

La seconde phase s'attache à sensibiliser l'étudiant au fait que l'examen physique est une partie intégrante de la rencontre médecin-malade, et qu'elle présente un inconfort particulier pour le patient qui va nécessiter une attention continue de la part du médecin, afin de diminuer l'anxiété et de mettre le patient à l'aise. C'est aussi l'occasion de faire discuter les étudiants sur leurs propres réactions au fait de toucher quelqu'un ou d'être soi-même touché, par exemple lors des exercices d'examen physique entre étudiants qui leur seront demandés pendant leurs études.

PHASE 1 : LES QUATRE OUTILS FONDAMENTAUX DE L'EXAMEN PHYSIQUE

Reprenez par exemple un cas de patient « grippé », sous forme de jeu de rôle.

Il pourrait s'agir d'un patient fictif déjà discuté lors des deux séminaires précédents qui revient voir son médecin après quelques jours de grippe, avec une fièvre persistante, une toux gênante et des expectorations verdâtres. Cette histoire clinique évoquant une surinfection broncho-pulmonaire bactérienne permettra :

- d'identifier les quatre outils de l'examen physique : l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation ;
- de discuter s'il y a un ordre logique pour examiner les signes pertinents :
 - en fonctions de systèmes différents (*dans cet exemple, O.R.L. et respiratoire*)
 - pour minimiser l'inconfort du patient, en respectant sa pudeur, tout en améliorant l'efficacité (meilleure gestion du temps).

PRATIQUE DE L'EXAMEN PHYSIQUE

Démonstration par le formateur, puis pratique des étudiants entre eux deux par deux:

1. désinfection des mains avant et après l'examen physique ;
2. gants en cas de lésions suintantes ;
3. *face* : inspection de la face (coloration de la peau, présence de sudations, coloration des conjonctives, inspection du pharynx) et examen ORL (ADP, pharynx, sans examen otoscope) ;
4. *cou*: inspection, puis palpation des aires ganglionnaires ;
5. *thorax* : inspection, palpation (ampliation thoracique), percussion, auscultation ;
6. prise de la tension artérielle selon les recommandations OMS.

Il peut être utile de présenter une systématique Tête-pieds, de parler de l'importance d'une systématique quelle qu'elle soit.

Pratiquement modéliser une première fois, puis faire faire à un-e étudiant-e devant tous les autres puis diviser le groupe et les mettre deux par deux pour les faire faire chacun.

PHASE 2 : PLACE DE L'EXAMEN PHYSIQUE DANS LA RENCONTRE MEDECIN-MALADE

Avec le formateur, les étudiants discutent ce qu'ils ont ressenti pendant cet exercice qui implique un contact corporel et un déshabillage partiel, et font le lien avec les difficultés particulières que l'examen représente pour le patient.

Aborder les sujets de pudeur, dimension culturelle. Aborder l'utilisation de la verbalisation explicite pour le patient (quoi dire ou ne pas dire pendant l'examen).

Clarifier la différence entre status pour les stations formatives (le formateur doit pouvoir évaluer chaque geste et il est bon de tout verbaliser) et le status en clinique pratique (rassurer le patient en lui disant ce qui est fait).

La reconnaissance que le fait de poursuivre le dialogue pendant cette phase de la rencontre permet non seulement de compléter la prise d'anamnèse, au vu des trouvailles de l'examen, mais aussi de rassurer le patient, amène l'étudiant-e à comprendre que l'examen physique s'inscrit dans la continuité de la rencontre médecin-malade.

C'est également l'occasion pour le formateur, de rappeler que l'anamnèse apporte dans la règle plus d'informations que l'examen physique, et qu'il est donc habituellement **dirigé** en fonction des plaintes du patient. Toutefois, on signalera que certains gestes de l'examen sont pratiqués à but de **dépistage**. On rappellera enfin que l'examen physique pratiqué chez un patient hospitalisé est plus complet que celui pratiqué au cabinet, et on justifiera cette différence :

- prévalence différente des pathologies dans ces deux milieux;
- dépistage;
- formation des étudiants et assistants à l'examen.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 14-24. WB 205 1
- Film "**Désinfection des mains: Comment ?**":
Sur le site de l'Unité « Croissance et Vieillissement Cellulaires », plate-forme Moodle

CONSULTATION MEDICALE 4

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pre Johanna Sommer, tél 022 / 379 57 14

THEME DU SEMINAIRE

- *Clôture de la consultation*

OBJECTIFS

- Savoir mettre un terme à une consultation.
- Exercer globalement les différentes étapes de l'explication et de la fin de l'entretien

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Séminaire de deux heures.
- Groupes d'environ 10 étudiants.
- Jeu de rôle.
- Pratique de l'explication et de la fin de la consultation.

METTRE UN TERME A LA CONSULTATION

Les étudiants s'exercent à résumer au patient les trouvailles de la consultation (anamnèse et examen physique) en évitant le jargon médical. Ils s'exercent à donner un diagnostic en prenant en compte les réactions du patient. Ils s'exercent à négocier une suite de prise en charge et à mettre fin à l'entretien. Si le temps le permet d'autres jeux de rôle peuvent être réalisés sur ce thème en lien avec des problèmes de l'unité. Par exemple:

- En état grippal au début pour travailler la fin simple.
- Cours n°1 : expliquer le diagnostic d'appendicite aiguë, proposer l'opération et répondre aux inquiétudes du patient.
- Cours n°3 : expliquer le diagnostic de psoriasis, justifier la biopsie, rassurer le patient sur la nature bénigne de sa maladie malgré son caractère stigmatisant.

En fonction du déroulement des jeux de rôles, les thèmes suivants peuvent être élaborés en deux étapes : l'explication et la fin de l'entretien.

FIN SIMPLIFIEE POUR COMMENCER

- **Annoncer la fin de la consultation** : faire une **synthèse** du problème (description des faits objectivés à l'anamnèse et à l'examen ; annoncer sa propre hypothèse sous forme d'hypothèse et sa proposition d'investigations et de traitement pour la suite qui doit encore être validé par le supérieur).
- **Anticiper la suite** (filet de sécurité).
- **Vérifier la compréhension** du patient de la suite de la prise en charge.
- **Phase sociale** (importance de quitter le patient dans le meilleur état émotionnel possible)

FIN COMPLEXE DE L'ENTRETIEN

- **Annoncer la fin de la consultation.**
- **Explication d'un diagnostic ou d'une investigation** :
 - *Informer* le malade sur ce qui a été trouvé (anamnèse et status)
 - Evoquer un diagnostic sous forme d'hypothèse :
 - explorer les connaissances et représentations du patient pour expliquer de façon ciblée ;
 - utiliser le langage du malade ;
 - pas trop d'information à la fois.
 - *Observer* les réactions du patient et *répondre* aux émotions.
 - *Vérifier* la compréhension du malade.
 - *Négocier et organiser* un plan (d'investigation, de traitement).
 - *Vérifier* l'adhésion au plan.
 - *Anticiper* les difficultés (adhésion au traitement etc.).
 - Anticiper la suite (filet de sécurité)
 - Vérifier la compréhension du patient de la suite de la prise en charge.
 - Phase sociale (importance de quitter le patient dans le meilleur état émotionnel possible)

Exercice pratique :

On définit en groupe une consultation qui aurait déjà eu lieu en définissant ensemble : le contexte socioprofessionnel et l'âge et le sexe du patient, puis la problématique médicale et les résultats de l'examen physique.

Pour l'exercice pratique, on peut le faire de différentes façons ;

- 1) Le formateur peut jouer le patient et les étudiants jouent tour à tour le soignant pour procéder à une partie de la fin de la consultation (et on se tourne après une ou deux phrases vers l'étudiant suivant).
- 2) Faire jouer la fin de l'entretien à quelques étudiants successivement.
- 3) Les étudiants jouent la fin de la consultation deux par deux.

Pour conclure on peut discuter avec le groupe de l'impact de la fin de la consultation, des enjeux, de ce qui est déterminé par la fin de l'entretien, des risques et difficultés.

On demandera en fin de séminaire ce qu'ils vont retenir pour leur pratique.